

Disclaimer

A ordem e como você estrutura sua anamnese é pessoal, esse modelo é apenas para servir de base para seu raciocínio

.

Montei esse modelo com base na seguinte referência: Porto CC, Porto AL.

Semiologia médica. 9a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2025

.

Ajustei alguns blocos para minha preferência pessoal + blocos de uso/costume do IAMSPE

ID:

Nome, idade, peso, altura, sexo, naturalidade, procedência, profissão.

LISTA DE PROBLEMAS:

- 1.
- 2.
- 3.

HMA:

Fonte: [paciente/familiar/cuidador], [confiabilidade da fonte]

Paciente com antecedentes de [CMB relevantes], admitido por [queixa principal / motivo da internação].

Previamente [independente/parcialmente dependente/dependente]

Refere início há [tempo], caracterizado por [descrição cronológica dos sintomas, intensidade, localização, irradiação, fatores de melhora/piora e sintomas associados].

Evoluiu com [progressão / novos sintomas / intercorrências].

Procurou atendimento devido a [motivo].

Na admissão, apresentava [estado clínico e principais achados objetivos].

Realizados [principais exames/intervenções], evidenciando [achados relevantes].

Indicada internação para [motivo/objetivo].

HPP:

- CMB:
- MUC:

- ALERGIAS:
- CIRURGIAS/INTERNAÇÕES PRÉVIAS:
- HÁBITOS:
 - Atividade física:
 - Tabagismo:
 - Etilismo:
 - Outras substâncias:
- FUNCIONALIDADE BASAL:

ATB / CULTURAS:

ATB:

- DD/MM | [droga]
 - ajustes/observações

CULTURAS:

- DD/MM | [material] | [resultado/pendente]

MARCOS DA INTERNAÇÃO

- DD/MM | [evento/intercorrência/procedimento/mudança/reposição/transfusão]

EVOLUÇÃO:

Encontro paciente em leito de enfermaria, [desacompanhado/acompanhado por], evoluindo [com melhora clínica/clinicamente estável/com piora clínica] e hemodinamicamente [estável/instável], [sem intercorrências/com intercorrências] nas últimas 24 horas. Encontra-se [consciente/sonolento], [contactuante/pouco contactuante/não contactuante] e [orientado/desorientado], [sem queixas atuais/com queixas atuais]. [Afebril/febril] no período, [sem episódios/com episódios] de [hipotensão/hipertensão/hipoglicemia/hiperglicemia/dessaturação/outros]. [Nega dor ou outras queixas álgicas/refere dor], de intensidade [leve/moderada/intensa]. Respira [confortavelmente/com desconforto respiratório] em [ar ambiente/O2 por cateter nasal/O2 por máscara/outro suporte], [sem dispneia/com dispneia], [sem necessidade de escalonamento do suporte de O2/com necessidade de escalonamento do suporte de O2]. Apresenta [boa/regular/baixa] aceitação da dieta [via oral/enteral/parenteral], [sem/com] náuseas e [sem/com] vômitos. Diurese [espontânea/por SVD], [presente/reduzida/ausente], [em volume habitual/aumentada/reduzida/não quantificada], [sem/com] queixas urinárias. [Evacuações presentes no período/sem evacuações no período], [sem alterações/com diarreia/com constipação/com alteração do aspecto das fezes]. [Deambula sem auxílio/deambula com auxílio/restrito ao leito], [sem limitações/com limitações], [sem/com] intercorrências durante mobilização.

Mantém ciclo sono-vigília [preservado/prejudicado/invertido], com [sono satisfatório/insônia/despertares frequentes/sonolência excessiva]. [Nega demais queixas no momento/refere outras queixas].

EF:

SSVV:

PA | FC | FR | SatO2 | Temp | HGT

GERAL:

[BEG/REG/MEG], [corado/hipocorado], [hidratado/desidratado], [anictérico/ictérico], [acianótico/cianótico], [afebril/febril].

NEURO:

Glasgow [15/14/13/12/11/10/9/8], [consciente/sonolento/torporoso/comatoso], [orientado/desorientado], [sem déficits focais evidentes/com déficits focais], [pupilas isocóricas e fotorreagentes/anisocóricas].

ACV:

Bulhas [normofonéticas/hipofonéticas/hiperfonéticas] em 2T, [rítmicas/arrítmicas], [sem/com] sopros, [sem/com] B3, [sem/com] B4. Perfusão periférica [preservada/limitrofe/prejudicada], TEC [$< 3s / > 3s$], pulsos periféricos [presentes e simétricos/diminuídos/assimétricos/ausentes].

AR:

MV [presente/diminuído/abolido] [bilateralmente/em base D/em base E/em hemitórax D/em hemitórax E], [sem RA/com crepitações/com sibilos/com roncos], [eupneico/taquipneico/bradipneico], [sem sinais de desconforto respiratório/com sinais de desconforto respiratório], em [AA/O2 por cateter nasal/O2 por máscara/VNI].

ABD:

[Plano/globoso/escavado], [às custas de panículo adiposo/distensão gasosa/ascite/visceromegalia/massa abdominal/gestação/bexigoma], [flácido/tenso], RHA [presentes/hipoativos/hiperativos/ausentes], [timpânico/submaciço/maciço] à percussão, [indolor/doloroso] à palpação [superficial/profunda], [sem/com] defesa, [sem/com] sinais de irritação peritoneal, [sem/com] massas palpáveis, [sem/com] visceromegalias, [sem/com] sinais de ascite.

Ressalva importante: **“globoso às custas de...” pressupõe que você tenha elementos semiológicos para atribuir a causa.** Em um paciente obeso evidente,

globoso às custas de panículo adiposo é adequado. Se não for possível determinar, é mais defensável simplesmente documentar **abdome globoso**

EXT:

[Sem/com] edema [MMII/MMSS], [simétrico/assimétrico], [+/4+ a ++++/4+].
Panturrilhas [livres/com sinais sugestivos de TVP]. Extremidades [aquecidas/frias],
pulsos periféricos [presentes/diminuídos/ausentes] e [simétricos/assimétricos].

ACESSOS/DISPOSITIVOS:

[Sem dispositivos invasivos/AVP/CVC/PICC/SVD/SNE/SNG/GTT/traqueostomia/dreno].

CVC [JID/JIE/SC direita/SC esquerda/femoral] | desde DD/MM

SVD | desde DD/MM

EXAMES:

LAB:

DD/MM:

IMAGEM:

DD/MM | EXAME: descrição objetiva dos principais achados.

OUTROS

DD/MM | BIOPSIA/ECG/SOROLOGIAS

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

- 1.
- 2.
- 3.

CONDUTAS:

- Mantenho cuidados e vigilância clínica/hemodinâmica
- Solicito [exames].
- Mantenho/inicio/suspendo [medicações].
- Profilaxia TEV:
- Dieta:
- Avaliação de [especialidade].